CRITICAL CARE NURSING · ESSAY PREDICTIONS

Critical Care Nursing Essay Questions — Predictions

تمريض الحالات الحرجة — توقعات الأسئلة المقالي

8	3	3	2
Predicted essays	Very high	High	Medium

طريقة التوقع: المقالي اللي جه فعلاً في فاينال 2021/2022 ترم تاني (VAP prevention) + المواضيع الأكتر تكراراً في 521 سؤال MCQ (ABG، ARDS، التنفس الصناعي، الـ stroke). امتحانات الكريتكال اللي في الجروب أغلبها MCQ والمقالي فيها قليل جداً، فالتوقعات هنا مبنية أساساً على التكرار. مفيش توقع مضمون 100%.

اللَّهُمَّ لا سَهْلَ إِلَّا ما جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وأنتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إذا شِئْتَ سَهْلًا — صلِّ على النبي ﷺ

Predicted Essay Questions

الأسئلة المتوقعة مرتبة حسب قوة التوقع

E1 **Interpret ABG results and list the steps of ABG interpretation, with causes of each acid-base disorder.** — توقع عالي جدا

المحاضرة: توازن الحمض والقاعدة واضطراباته (Acid-Base Balance & its Disorders) — حوالي 100 سؤال ABG في البنك + ملف ABG scenarios.

المصدر: توقع من الـ MCQ

E2 **Mention at least four evidence-based nursing interventions to prevent ventilator-associated pneumonia (VAP).** — توقع عالي جدا

المحاضرة: اضطرابات الجهاز التنفسي والتنفس الصناعي (Respiratory Disorders & Mechanical Ventilation) — جه فعلاً في الفاينال + أسئلة MCQ عن الـ VAP في كويزات 2022 و2024.

المصدر: فاينال 2021/2022 ترم تاني

E3 **Discuss ARDS: causes, diagnostic criteria (Berlin), and nursing management.** — توقع عالي جدا

المحاضرة: اضطرابات الجهاز التنفسي والتنفس الصناعي (Respiratory Disorders & Mechanical Ventilation) — أكتر موضوع متكرر في الميدترمات والكويزات والفاينال.

المصدر: توقع من الـ MCQ

E4 **Describe the stages of assessment of the critically ill patient and the admission quick check (ABCDE).** — توقع عالي

المحاضرة: تقييم المريض الحرج (Assessment of Critically Ill Patients) — محاضرة الـ assessment عليها أسئلة كتير.

المصدر: توقع من الـ MCQ

E5 توقع عالي

Compare the modes of mechanical ventilation and mention the causes of high- and low-pressure alarms.

المحاضرة: اضطرابات الجهاز التنفسي والتنفس الصناعي (Respiratory Disorders & Mechanical Ventilation) — متكرر جداً في الكويزات.

المصدر: توقع من الـ MCQ

E6 توقع عالي

Discuss the nursing management of a patient with acute stroke.

المحاضرة: الاضطرابات العصبية (Neurological Disorders) — كويز Stroke + فاينال 2022 + ملف أسئلة مهمة.

المصدر: توقع من الـ MCQ

E7 توقع متوسط

Explain triage categories (START) and the primary and secondary surveys of a trauma patient.

المحاضرة: الإصابات العامة والفرز (General Traumas & Triage) — محاضرة Trauma & Triage.

المصدر: توقع من الـ MCQ

E8 توقع متوسط

Discuss the nursing management of chest trauma (tension pneumothorax, flail chest) and chest tube care.

المحاضرة: إصابات محددة (Specific Traumas) — محاضرة Specific traumas.

المصدر: توقع من الـ MCQ

Model Answers

نقاط الإجابة النموذجية

E1. Interpret ABG results and list the steps of ABG interpretation, with causes of each acid-base disorder.

- Step 1: pH — acidosis <7.35, alkalosis >7.45
- Step 2: PaCO2 (35–45) — respiratory component
- Step 3: HCO3 (22–26) — metabolic component
- Step 4: match the cause, then check compensation (none/partial/full) or mixed
- Resp acidosis: COPD, opioids, hypoventilation
- Resp alkalosis: anxiety, pain, fever
- Met acidosis: DKA, diarrhea, renal failure, shock
- Met alkalosis: vomiting, NG suction

E2. Mention at least four evidence-based nursing interventions to prevent ventilator-associated pneumonia (VAP).

- Elevate HOB 30–45°
- Daily sedation interruption and assessment of readiness to wean
- Oral care with chlorhexidine
- Subglottic secretion drainage; keep cuff pressure 20–30 cmH2O
- Hand hygiene and aseptic suctioning
- Peptic ulcer and DVT prophylaxis
- Avoid unnecessary circuit changes; drain condensate away from patient

E3. Discuss ARDS: causes, diagnostic criteria (Berlin), and nursing management.

- Direct: pneumonia, aspiration, inhalation; indirect: sepsis (major), trauma, pancreatitis
- Early sign: increased RR; refractory hypoxemia
- Berlin: within 1 week, bilateral infiltrates, non-cardiogenic, P/F ratio
- Mild 200–300, moderate 100–200, severe <100
- Lung-protective ventilation: VT 4–6 mL/kg, plateau <30, PEEP, FiO2 <60%
- Prone positioning
- Suction, sedation, fluid balance, nutrition

E4. Describe the stages of assessment of the critically ill patient and the admission quick check (ABCDE).

- Pre-arrival, admission quick check, comprehensive admission, ongoing
- Airway patency
- Breathing: rate, pattern, SpO2
- Circulation: HR, BP, perfusion
- Disability: GCS, pupils
- Exposure/equipment check, drugs and doses

E5. Compare the modes of mechanical ventilation and mention the causes of high- and low-pressure alarms.

- AC: set VT and rate with every breath
- SIMV: mandatory breaths + spontaneous
- PSV: pressure support for spontaneous breaths
- CPAP: continuous pressure in spontaneous breathing (weaning)
- PEEP: keeps alveoli open; risk hypotension/barotrauma
- High pressure: secretions, kinking, biting, bronchospasm, coughing
- Low pressure: disconnection, cuff leak

E6. Discuss the nursing management of a patient with acute stroke.

- Airway and oxygen (priority)
- Neuro assessment & GCS
- BP control; tPA within window (ischemic only) — check BP <185/110
- Swallow screen/gag reflex before feeding
- Positioning, ROM, prevent contractures
- Communication strategies for aphasia
- Hemianopia: scanning; neglect: care for affected side
- Family support & rehabilitation

E7. Explain triage categories (START) and the primary and secondary surveys of a trauma patient.

- Red: immediate
- Yellow: delayed
- Green: minor (walking)
- Black: dead/expectant
- Primary: ABCDE
- Secondary: head-to-toe, AMPLE history, vital signs

E8. Discuss the nursing management of chest trauma (tension pneumothorax, flail chest) and chest tube care.

- Tension PTX: needle decompression then chest tube
- Flail chest: analgesia, O2, ventilation
- Chest tube: keep below chest, sterile water seal
- Tidaling normal; continuous bubbling = air leak
- Monitor drainage amount/color